SDD 306 - Sujet n°1

Spécialité : Rhumatologie

Date : 06/02/2026
Auteur : Marie GRI (interne en rhumatologie à Nice)
Relecteur(s) : Dr EVENOR (CCA Rhumatologie Nice), Hamza MAKHLOUK (VP ECOS TACFA, interne en cardiologie à Paris)

Domaine d'apprentissage principal	Entretien/Interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	Iconographie
Item en lien avec la station	128- Ostéopathie fragilisante
Situation de départ en lien avec la station	306- Dépistage et prévention de l'ostéoporose
Matériel nécessaire à la station	IRM, biologie
Contexte de la station	Avec PS (patient standardisé)

Pour rappel, les domaines d'apprentissage sont :

- Entretien/interrogatoire
- Examen clinique
- Iconographie
- Procédure
- Stratégie diagnostique
- Stratégie pertinente de la prise en charge
- Synthèse des résultats d'examens paracliniques
- Education/prévention
- Annonce/information au patient
- Urgence vitale
- Communication interprofessionnelle

La liste des items de l'EDN se trouve ICI
La liste des situations de départ se trouve ICI

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Vous êtes médecin rhumatologue.

Vous recevez la patiente, Mme X, âgée de 80 ans au cabinet qui présente une douleur lombaire post chute mécanique de sa hauteur, il y a 2 semaines.

Consignes :

Vous avez 8 minutes pour :

- Décrire les deux examens apportés par la patiente
- Annoncer le diagnostic à votre patiente
- Chercher les facteurs de risque en lien avec votre diagnostic

Vous ne devez pas :

- proposer un traitement
- prescrire des examens complémentaires
- rechercher les diagnostics différentiels

Attention : Vous avez 8 minutes incluant la lecture de ces consignes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec patient standardisé.

1/ IRM de Mme X :

2/ Biologie de Mme X :

- Hémoglobine 12,44 g/dl
- Leucocytes à 8 G/l
- Plaquettes 176 G/l
- EPS sans particularité
- Ionogramme normal
- Bilan hépatique dans les normes excepté des PAL à 156 UI/l
- TSH à 2.82 mUI/l
- 25 OH vitamine D à 18 ng/l (norme > 30 ng/l)
- Créatinine à 156 mg/l soit un MDRD à 55 ml/min/1,73 m^2
- CRP < 0,5 mg/l
- Calcémie corrigée à 2,42 mmol/l
- Phosphatémie dans les normes

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques			
1.	IRM dorsolombaire en coupe sagittale en fenêtre T2 au nom de Mme X	1 pt	☐
2.	Identitovigilance : IRM au nom de Mme X	1 pt	☐
3.	Diminution de taille de la vertèbre L5 évoquant une fracture vertébrale	1 pt	☐
4.	Hypersignal en T2 STIR de la vertèbre L5 évoquant une activité de la fracture	1 pt	☐
5.	Aspect évocateur d'une origine ostéoporotique de cette fracture : avec au moins 1 élément : fracture située sous la 3e vertèbre thoracique, absence d'ostéolyse avec signe du puzzle, respect du mur postérieur	1 pt	☐
6.	Biologie retrouvant une carence en vitamine D	1 pt	☐
7.	Biologie retrouvant des phosphatases alcalines élevées compatibles avec une fracture récente	1 pt	☐
8.	Évocation du diagnostic : Fracture vertébrale de L5 active d'allure ostéoporotique.	1 pt	☐
9.	Évocation du diagnostic : bilan d'ostéopathie fragilisante ne retrouvant pas de cause secondaire à cette fracture.	1 pt	☐
10.	Facteurs de risques de l'ostéoporose demandés : (0,5 point par item), uniquement si mentionné clairement - Antécédent familial de fracture par fragilité osseuse - Antécédent personnel de fracture - Faible poids - Ménopause précoce - Hyperparathyroïdie primitive, hyperthyroïdie, diabète de type 1 et 2, maladie de Cushing, hypogonadisme. - Tabagisme - Consommation excessive d'alcool. - Médicaments : corticothérapie, inhibiteur de l'aromatase, analogue de la LH-RH. - Maladies neurologiques : immobilisation très prolongée, maladie de Parkinson. - Maladies inflammatoires : polyarthrite rhumatoïde, BPCO > stade 1. - Nutritionnelles : carence en protéines, faible apport calcique, carence en vitamine D. - Risque de chute : troubles de l'acuité visuelle, troubles neuromusculaires.	6 pts	☐
Communications et attitudes			

8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

3. APTITUDE À FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS AU PATIENT / AUX AIDANTS

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Renseigne le patient / aidant de manière inadaptée (ex. informations inexactes) ou ne fait aucun effort pour renseigner le patient/aidant	Donne des renseignements de façon incomplète ou s'attarde à des renseignements éloignés du problème	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille quelque peu à ce que le patient /aidant comprenne	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille à ce que le patient / aidant comprenne	Renseigne avec justesse et illustre ses explications pour qu'elles soient bien comprises

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

TOTAL	**…./13 points**

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué.
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Vous êtes adressée par votre médecin traitant après réalisation d'une IRM dorsolombaire (examen d'imagerie dont vous ne vous souvenez pas du nom) et d'une biologie dans les suites de votre chute mécanique en vous prenant les pieds dans le tapis il y a deux semaines.
Le médecin va vous diagnostiquer normalement une ostéoporose fracturaire et va chercher les facteurs de risque de cette ostéoporose.

Plan de la station ECOS :

Patient simulé assis sur une chaise en face de l'étudiant.

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

Bonjour Docteur. Merci de me recevoir, je suis Mme X, j'ai chuté il y a deux semaines en me prenant les pieds dans le tapis. Depuis j'ai très mal au dos. Mon médecin traitant m'a prescrit ces deux examens qu'il m'a demandé que je vous apporte : qu'en pensez-vous ?

Identité du patient :

Mme X, 80 ans, 1m 70, 46 kg

Mode de vie :

Secrétaire médicale retraitée, randonnées 3 fois par semaine, 3 enfants, 1 mari, fume 10 cigarettes par jour depuis 20 ans, alcool occasionnel (moins d'1 verre par semaine), absence d'allergie

Comportement global :

Patiente calme, posée, répondant aux questions

Antécédents personnels :

- Adénocarcinome utérin pris en charge par hystérectomie et ovariectomie à 38 ans
- Absence d'antécédent personnel de fracture
- Faible apport calcique ("je digère mal le lait")
- Carence en vitamine D connue mais non supplémentée ("c'est mauvais docteur beurk")
- Absence de problèmes visuels, neuromusculaires, immobilisation très prolongée, consommation de corticothérapie au long cours
- Fibrillation atriale
- Insuffisance rénale stade 3A
- Insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée FEVG 35% suite à un SCA ST + en 2022

Antécédents familiaux :

- Fracture du col du fémur à 72 ans chez sa mère

Médicaments :

Eliquis 2.5mg 10 1
Paracétamol 500 mg 1 1 1
Izalgi 1 1 1
Aspirine 75 mg 1 0 0
Entresto 97/103 mg 1 0 0
Dapagliflozine 10mg 1 0 0
Bisoprolol 1.25mg
Spironolactone 25mg 0 0 1

Symptômes positifs :

Si questions sur la douleur, dire "je ne sais pas trop comment vous la décrire".
Si questions sur des diagnostics différentiels de l'ostéoporose (infection, AEG), dire que tout est normal.

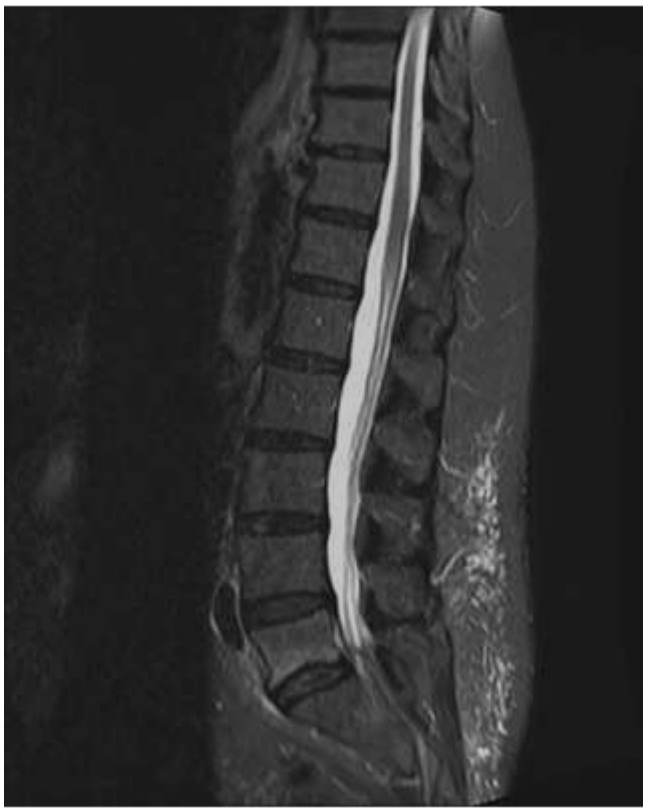
Constantes :

Normales

Données complémentaires :

Remettre initialement la biologie et IRM dorsolombaire.

1/ IRM de Mme X :



2/ Biologie de Mme X :

- Hémoglobine 12,44 g/dl
- Leucocytes à 8 G/l
- Plaquettes 176 G/l
- EPS sans particularité
- Ionogramme normal
- Bilan hépatique dans les normes excepté des PAL à 156 UI/l
- TSH à 2.82 mUI/l
- 25 OH vitamine D à 18 ng/l (norme > 30 ng/l)
- Créatinine à 156 mg/l soit un MDRD à 55 ml/min/1,73 m^2
- CRP < 0,5 mg/l
- Calcémie corrigée à 2,42 mmol/l
- Phosphatémie dans les normes

Questions de relance :

Que pensez-vous de mon imagerie ?
Que pensez-vous des résultats de ma prise de sang ?
Et alors docteur, quel est le diagnostic ?